

CAPÍTULO 5.1

Disección Aórtica

PERFIL EUNACOM 1.01.2.002

Dx: Específico • Tx: Inicial • Seg: Derivar

Introducción

La **disección aórtica** es una de las emergencias cardiovasculares más críticas. Su importancia radica en dos pilares fundamentales para el examen EUNACOM: 1. **Alta letalidad**: Es una enfermedad extremadamente grave que requiere diagnóstico y manejo inmediato. 2. **Diagnóstico diferencial crítico**: Clínicamente puede confundirse con un **Síndrome Coronario Agudo** (infarto), pero su tratamiento es diametralmente opuesto.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El manejo estándar de un infarto (Aspirina, Clopidogrel, Heparina y Trombolíticos como la Estreptoquinasa) está **absolutamente contraindicado** en la disección aórtica. Administrar estos fármacos a un paciente con disección puede provocar una hemorragia masiva y la muerte, constituyendo una negligencia médica grave.

Fisiopatología y Causas

La disección ocurre cuando se produce un desgarro en la túnica íntima de la aorta, permitiendo que la sangre penetre en la capa media y cree una **falsa luz** (flap de disección).

NOTA CLÍNICA

Zonas de Cizalle: La disección suele ocurrir en puntos donde una parte de la aorta es fija y la otra móvil: - **Bajo la subclavia izquierda**: El lugar más frecuente (el arco es fijo por los vasos del cuello, la aorta descendente es más móvil). - **Raíz aórtica**: El corazón se mueve independiente de la aorta ascendente. - **Hiato diafragmático**: Diferencia de movilidad entre la aorta torácica y abdominal.

Factores de Riesgo y Etiología

- **Hipertensión Arterial (HTA)**: El factor de riesgo más importante y frecuente (causa degenerativa). - **Traumatismo torácico**: Por mecanismos de desaceleración. - **Enfermedades genéticas del tejido conectivo**: - **Síndrome de Marfan**: Alteración de la fibrilina/elastina (herencia autosómica dominante habitualmente). - **Síndrome de Ehlers-Danlos**. - **Enfermedad de Erdheim** (necrosis quística de la media).

Cuadro Clínico

El diagnóstico se basa en una alta sospecha clínica ante un dolor torácico con características específicas:

- **Dolor Torácico**: Súbito, de intensidad máxima desde el inicio, carácter **lansinante** o pulsátil.
- **Irradiación**: Típicamente **transfixiante** (atraviesa del pecho al dorso) y migratorio (hacia la espalda y luego hacia abajo siguiendo el trayecto de la aorta).
- **Sensación de muerte inminente**.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Triada de sospecha en el examen: 1. **Soplo diastólico de insuficiencia aórtica**: Indica compromiso de la raíz aórtica. 2. **Asimetría de pulsos**: Diferencia de presión o pulso entre ambos brazos (radiales) o entre extremidades superiores e inferiores. 3. **Crisis hipertensiva**: Aunque el infarto puede cursar con HTA, una crisis severa asociada a dolor transfixiante debe hacernos pensar primero en disección.

Otras manifestaciones:

- **Disfonía**: Por parálisis del nervio laríngeo recurrente (especialmente el izquierdo al pasar bajo el cayado aórtico). - **Síncope o muerte súbita**: Por rotura hacia el pericardio

(**Taponamiento pericárdico**). - **Isquemia de órganos diana**: Si el flap obstruye el origen (ostium) de otras arterias, puede haber: - Isquemia renal (falla renal aguda). - Isquemia mesentérica (dolor abdominal intenso). - Isquemia coronaria (puede simular o causar un infarto real si afecta las coronarias).

Diagnóstico

Ante la sospecha, el estudio debe ser rápido:

- **Electrocardiograma (ECG)**: Generalmente muestra **taquicardia sinusal** sin signos de isquemia. Esto ayuda a diferenciarlo del infarto. (Excepción: si la disección diseca las coronarias, puede haber supradesnivel del ST).
- **Radiografía de Tórax**: Se observa **ensanchamiento del mediastino** o un botón aórtico prominente/irregular.
- **Angiotac de Tórax (Gold Standard)**: Es el examen de elección por su rapidez y alta sensibilidad/especificidad en el servicio de urgencia.
- **Ecocardiograma Transesofágico (ETE)**: De elección si el paciente está **hemodinámicamente inestable** (chocado), ya que puede realizarse a la cabecera del paciente sin trasladarlo al tomógrafo.

Clasificación y Tratamiento

El manejo depende fundamentalmente de la localización (Clasificación de Stanford).

TABLA 5.1.1: TIPO DE DISECCIÓN VS LOCALIZACIÓN

TIPO DE DISECCIÓN	LOCALIZACIÓN	MANEJO INICIAL
Tipo A	Afecta la aorta ascendente (antes de la subclavia izquierda).	Quirúrgico de Urgencia (Cirugía a pecho abierto + prótesis).
Tipo B	Afecta solo la aorta descendente (después de la subclavia izquierda).	Médico (en la mayoría de los casos).

Manejo Médico (Fundamental en Tipo B y previo a cirugía en Tipo A)

1. **Control de la Presión Arterial**: El objetivo es estricto, buscando una **PA < 120/80 mmHg** para disminuir la fuerza de eyección y que la disección no progrese. Se utilizan antihipertensivos endovenosos (ej. Labetalol, Nitroprusiato). 2. **Analgesia**: Generalmente con opioides potentes para controlar el dolor y el tono simpático.

¿Cuándo se opera una Tipo B?

Aunque la Tipo B es de manejo médico, se requiere cirugía (habitualmente endovascular) si presenta complicaciones: - Dolor persistente e intratable. - Isquemia de órganos (renal, mesentérica, extremidades). - Signos de rotura inminente o expansión rápida.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Recuerda: Lo que define una **Tipo A** es que **comience** o involucre la aorta ascendente. Si una disección parte en la raíz aórtica y llega hasta las ilíacas, sigue siendo **Tipo A** y es de resorte quirúrgico.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

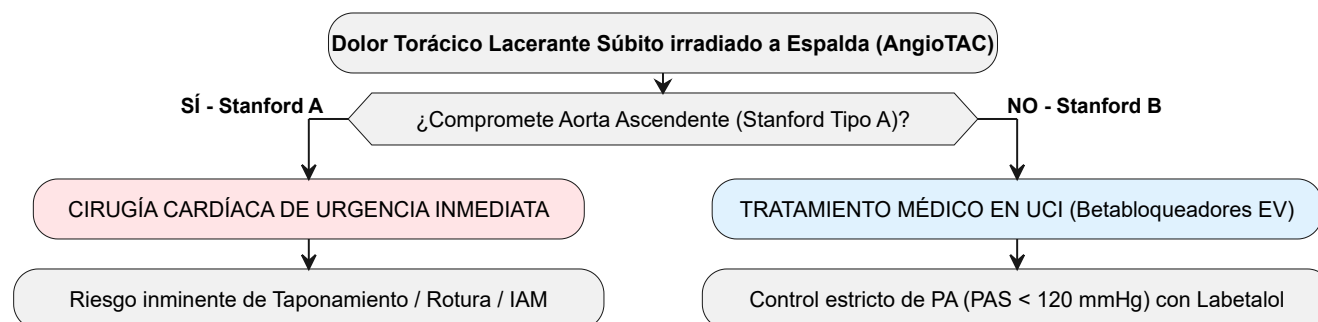
"Hombre de 60 años con dolor torácico lacerante 10/10 irradiado a espalda y asimetría de pulso."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Disección Aórtica. Stanford A (ascendente: Cirugía urgente) vs Stanford B (descendente: Betabloqueadores EV Labetalol).

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La HTA es el factor de riesgo más importante (70-80%)
- Stanford A: compromete aorta ascendente (emergencia quirúrgica); B: solo descendente
- El dolor es súbito, desgarrante, de máxima intensidad desde el inicio
- La asimetría de pulsos y PA entre extremidades es muy sugerente
- El angio-TAC de tórax es el examen de elección
- Betabloqueadores EV son primera línea para control de PA y FC
- Tipo A siempre es cirugía de emergencia; tipo B no complicada es manejo médico
- Nunca usar nitroprusiato solo (sin betabloqueador previo) por taquicardia refleja

FIGURA 5.1B: ALGORITMO DE DISECCIÓN AÓRTICA: STANFORD A VS STANFORD B**EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (DISECCIÓN AÓRTICA)****PREGUNTA 1**

Hombre de 62 años, hipertenso, presenta dolor torácico súbito desgarrante de máxima intensidad desde el inicio, irradiado a espalda. PA brazo derecho 180/100, brazo izquierdo 140/80. Angio-TAC muestra disección desde aorta ascendente hasta descendente. ¿Cuál es la conducta?

- ☐ A) Manejo médico con betabloqueadores y control estricto de PA
- ☐ B) Cirugía de emergencia con reemplazo de aorta ascendente
- ☐ C) Reparación endovascular con stent (TEVAR)
- ☐ D) Trombolisis sistémica
- ☐ E) Coronariografía urgente

PREGUNTA 2

¿Cuál es el fármaco de primera línea para el manejo inicial de la disección aórtica?

- ☐ A) Nitroprusiato de sodio
- ☐ B) Nifedipino sublingual
- ☐ C) Labetalol o esmolol endovenoso
- ☐ D) Hidralazina endovenosa
- ☐ E) Captopril sublingual

PREGUNTA 3

¿Cuál es la diferencia principal entre el dolor de la disección aórtica y el del infarto agudo de miocardio?

- ☐ A) La disección se irradia al brazo izquierdo
- ☐ B) El dolor de disección es de máxima intensidad desde el inicio; el del IAM es crescendo
- ☐ C) El dolor de disección mejora con nitroglicerina
- ☐ D) El IAM nunca se irradia a la espalda
- ☐ E) No hay diferencia, son indistinguibles clínicamente

RESUMEN: DISECCIÓN AÓRTICA

La disección aórtica es un desgarramiento de la capa íntima de la aorta que permite la entrada de sangre a la capa media, creando una falsa luz que puede propagarse distal o proximalmente. La hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante. Se clasifica según Stanford en tipo A (compromete aorta ascendente, independiente del origen) y tipo B (solo aorta descendente, distal a la subclavia izquierda). El diagnóstico se sospecha ante dolor torácico súbito, desgarrante, de máxima intensidad desde el inicio, que puede irradiarse a la espalda. La asimetría de pulsos y de presión arterial entre extremidades es muy sugerente. El angio-TAC de tórax es el examen de elección por su rapidez y disponibilidad, mostrando el flap intimal y la doble luz. El ecocardiograma transesofágico es alternativa en pacientes inestables. El tratamiento inicial es control agresivo de la presión arterial y frecuencia cardíaca con betabloqueadores endovenosos (labetalol o esmolol) para reducir la fuerza de cizallamiento sobre la pared aórtica. La disección tipo A es una emergencia quirúrgica que requiere cirugía inmediata. La tipo B no complicada se maneja médicamente con control estricto de presión arterial. La tipo B complicada puede requerir reparación endovascular con stent.